

SH.GSR.03.ICD.19			رقم السياسة
النتائج الحرجة			عنوان السياسة
٢	رقم الإصدار	٢٠٢٦/٠٣/٠١	تاريخ إعداد
٢٠٢٦/٠٤/٠١	تاريخ اعتماد	٢٠٢٦/٠٤/٠١	تاريخ تفعيل
٧	عدد الصفحات	٢٠٢٩/٠٤/٠١	تاريخ المراجعة
جميع الأقسام الاكلينيكية ب المستشفى			نطاق التفعيل
اعتماد	مراجعة	إعداد	
مدير المستشفى د/ وسام وهيبه	لجنة الجودة د/ ايمان سامي	مدير الشؤون العلاجية د/ محمد مختار رئيسة التمريض م/ هيام محمود فريق الجودة د/ باسل محمد - م/ ولاء سيد	



د/ ايمان سامي السيد
 مديرة الجودة
 مستشفى صيدناوى

السياسة

- تلتزم مستشفى صيدناوى بتحديد النتائج الحرجة والتزام العاملين بالإبلاغ عنها بطريقة آمنة على مدار الـ ٢٤ ساعة جميع أيام السنة وتدوينها بسجلات النتائج الحرجة وملفات المرضى مع وصف تسلسل نقل النتيجة واتخاذ اللازم نحو المرضى.
- يلتزم العاملين ب مبادئ الأوامر التبليغ الشفوي اثناء التبليغ ب النتائج الحرجة : ابلاغ من مكتشف النتيجة ، ثم إعادة القراءة من مستلم النتيجة (قراءة عكسية)، ثم التأكيد من المبلغ
- يلتزم ملتزم النتيجة ب تسجيل النتائج الحرجة في النموذج الخاص بها مع الالتزام بالعناصر التالية
 - اسم المريض صاحب النتيجة الحرجة ورقمه الموحد
 - تاريخ وقت الإبلاغ.
 - تحديد هوية الموظف المسؤول الذي قام بالإبلاغ.
 - تحديد هوية الشخص الذي تم إبلاغه.
 - نتيجة الفحص
 - الاجراء المتخذ
 - عملية التبليغ وأي صعوبات واجهت المبلغ اثناء التبليغ
- يلتزم رؤساء اقسام المستشفى بالمشاركة وتحديد قوائم للنتائج الحرجة (فسيولوجية، معملية، أشعة) تكون مرجع لجميع العاملين بالنتائج التي تتطلب تدخلا فوريا

الغرض

- الحفاظ علي سلامة وأمان المريض واتخاذ الإجراء المناسب عند وجود نتائج ذات دلالة حرجة تتطلب تدخل الطبيب المعالج أو أي عضو من الفريق الطبي بسرعة.

التعريفات

- النتائج الحرجة (Panic Values): هي النتائج التي قد تشير إلى وجود وضع يهدد حياة المريض وذلك يتطلب استجابة عاجلة أو تدخل سريع من قبل الطبيب المعالج.

- في حالة وجود أي نتيجة ذات دلالة حرجة طبقا للقوائم السابقة يقوم المسؤول (طبيب معمل/طبيب الأشعة/الطبيب المقيم/المرضة المسؤولة) بإبلاغ الطبيب المعالج أو الطبيب المقيم أو ممرضة القسم فوراً وبعد أقصى خلال ١٥ دقيقة من ظهور النتيجة.
- يتأكد المبلغ من التأكد من الاسم الثلاثي للطبيب المعالج أو الطبيب المقيم والمرضة المسؤولة متلقي البلاغ.
- يقوم متلقي البلاغ بتسجيل النتيجة الحرجة فوراً في ملف المريض بعد التأكد من بيانات المريض بالاسم رباعي ورقم الموحد.
- يقوم متلقي البلاغ بإعادة قراءة بيانات المريض ونتيجة الاختبار على المبلغ (Read back) وذلك بهدف التأكد من أن كل ما تم تلقيه وتدوينه في ملف المريض صحيح ودقيق وذلك طبقاً لطريقة التوثيق بسياسة الأوامر الشفهية والتليفونية
- من حق الطبيب المعالج أو الطبيب المقيم قبول النتيجة أو رفضها على ضوء مدى تناسبها مع حالة المريض مما قد يتطلب إعادة الفحص أو الإجراء من المبلغ.
- يحق لقسم المعمل طلب إعادة الفحص في حال اشتباه مدى صحة النتيجة
- التوثيق:
 - يوثق المتلقي (الطبيب المعالج أو الممرضة المسؤولة) في ملف المريض وسجل النتائج الحرجة البيانات الآتية فوراً عند تلقي البلاغ
 - اسم المريض الرباعي والرقم الموحد
 - اسم التحليل
 - النتيجة وساعة ظهورها
 - اسم المبلغ (المعمل / الأشعة)
 - اسم الممرض أو الطبيب متلقي النتيجة
 - اسم الطبيب الذي تم تبليغه (في حال تلقي النتيجة من قبل ممرض)
 - وقت التبليغ
 - الاجراء المتخذ
 - أي معوقات في عملية التبليغ
 - يسجل الطبيب أي إجراءات متخذة حيال النتيجة ب نموذج أوامر الطبيب
 - يسجل الممرض/ الممرضة المسؤولة عن المريض وقت إبلاغ الطبيب بالنتيجة الحرجة في ملاحظات التمريض، كما يتم تسجيل أي إجراءات تم عملها بناء على أوامر الطبيب

- يوضع نموذج خاص للنتائج الحرجة في ملف المريض يحتوي على معامل النتائج الحرجة مجمعة، ويجب الالتزام ب عناصر تسجيل النتيجة كما تم الذكر في بيانات السياسة وكما يتطلب النموذج
- في الأقسام المبلغة (المعمل / الأشعة)
- يتم تفعيل سجل النتائج الحرجة، ويتم تسجيل العناصر الآتية عند التبليغ ب أي نتيجة
- اسم مسئول المعمل /الأشعة الذي قام بالإبلاغ.
- الاسم الرباعي للمريض ورقم الموحد
- نتيجة الفحص.
- وقت الإبلاغ بالساعة والدقيقة.
- الاسم الثلاثي (للطبيب أو الممرضة) متلقي البلاغ.
- القسم او الوحدة
- أي صعوبات اثناء التبليغ

المسؤول عن التنفيذ

- المعمل والأشعة.
- الأطباء.
- التمريض.

المراقبة والتقييم

- تقوم المستشفى بتتبع وجمع وتحليل وعمل تقرير عن البيانات المتعلقة بعملية الإبلاغ عن النتائج الحرجة
- KPI: يتم عمل كارت لمؤشر له علاقة بعملية مرتبطة بالسياسة مع متابعة تحقيق الهدف المراد و نسبته الناتجة من قيمة المؤشر عند القياس لضمان التحسين المستمر
- تعمل المستشفى على فرص التحسين المحددة في عملية الإبلاغ عن النتائج الحرجة.

النماذج / مرفقات

- قوائم النتائج الحرجة
- نموذج التبليغ عن نتائج حرجة

معايير ذات صلة

ICD.18 Verbal and telephone orders, DAS.07 Medical imaging reports; DAS.22 STAT results

المراجع

- دليل معايير اعتماد المستشفيات - الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية (GAHAR)، إصدار ٢٠٢٥. (معيار ICD.19).

CRITICAL VALUES LIST

1 - HEAMATOLOGY			2 - CHEMISTRY			4 - MICROBIOLOGY	
Haemoglobin	< 7 g/dl	> 20 g/dl	Troponin	positive		Blood culture	Positive growth for G-ve bacteria or fungi (Each event)
Haemoglobin (in dialysis patients)	< 8 g/dl	> 25 g/dl	Blood glucose (adults)	< 40 mg/dl	> 500 mg/dl	Any sterile fluid as Blood, CSF, ascetic, peritoneal, synovial	Positive direct film or growth for any bacterial or fungi (Each event)
Haemoglobin (newborn until 2 weeks)	< 12 g/dl	> 25 g/dl	Blood glucose (pediatrics)	< 46 mg/dl	> 445 mg/dl	Any sample for Z.N stain or T.B culture	Positive stain or growth (first Positive)
Haemoglobin (2 weeks until 6 weeks)	< 8 g/dl	> 25 g/dl	Blood glucose (newborn)	< 30 mg/dl	> 325 mg/dl	Any sample	Multi-drug resistance as G+VE as MRSA, VISA/VRSA and VRE. Or G-VE as ESBL, AmpC, CRE, CRP and CRA (Each event)
Haemoglobin (6 weeks - 18 years old)	< 8 g/dl	> 20 g/dl	Csf glucose (adults)	< 40 mg/dl	> 200 mg/dl	Any sample for gram staining or culture	Identification on unusual isolates as Brucella, Diphtheria, salmonella, v. cholera (Each event)
HCT	< 18 %	> 75 %	Csf glucose (pediatrics)	< 31 mg/dl		Any sample for staining or culture	Detection of clinically signification fungias, Histoplasma, Histoplasma, Blastomyces, Coccidioides, Cryptococcus and Pneumocystis jirovecii (first event)
HCT in dialysis patients	< 20 %	> 75 %	t.protein	< 3.4 g/dl	> 9.5 g/dl	Gram stain or culture for eye swabs or scrapings	Positive result
HCT (newborns - 2 weeks)	< 33 %	> 75 %	creatinine adults		> 5 mg/dl	Any sample for gram staining or culture	Potential bioterrorism agent as bacillus anthracis, Yersinia pestis, Brucella species. (Each event)
HCT (2 weeks - 18 years)	< 25 %	> 75 %	creatinine 12 to 15 years old		> 3.8 mg/dl	Clostridium perfringens or tetaniin gram-stained film from wound discharge.	
TLC	< 1x10 ⁹ /cmm	> 50x10 ⁹ /cmm	creatinine 2 to 11 years old		> 2.5 mg/dl	Serology	Positive CSF for N.Meningitis (first time), or Positive confirmed HIV
TLC (newborns - 18 years old)	< 2x10 ⁹ /cmm	> 30x10 ⁹ /cmm	creatinine 5 weeks to 23 months old		> 1.5 mg/dl	5 - STOOL	
Platelets	< 20x10 ⁹ /cmm	> 1000x10 ⁹ /cmm	creatinine 1 day old to 4 weeks old		> 100 mg/dl	6 - URINE	
PT		> 60 seconds	BUN adults		> 55 mg/dl	Positive results for glucose in urine of newborns	
INR		> 5	BUN pediatrics		> 13 mg/dl	Presence of pathologic crystals (cysteine, leucine or tyrosine) on urinalysis	
PTT		> 100 seconds	Uric acid		> 12 mg/dl	Positive ketone with glucose	
PTT (Newborns - 18 years old)		> 62 seconds	Uric acid (pediatrics)	< 1 mg/dl	> 9 mg/dl		
RBC's Morphology		> 6 spherocytes	PO4	< 2.8 mmol/l	> 6.2 mmol/l		
Absolute Neutrophil Count	≤ 0.5x10 ⁹ /cmm		Potassium	< 2.8 mmol/l	> 7.8 mmol/l		
Fibrinogen	≤ 60 mg/dl		potassium (newborn until 18 years old)	< 120 mmol/l	> 160 mmol/l		
Slide differential	any blasts - any signs of malaria		sodium	< 125 mmol/l	> 150 mmol/l		
3 - BLOOD GASES			sodium (newborn until 18 years old)	< 125 mmol/l	> 1000 IU/l		
PH	< 7.2	> 7.6	LDH	< 6.5 mg/dl	> 24 U/ml		
Po2 arterial	< 40 mmHg	> 90 mmHg	Calcium (if patient is on dialysis, this should be accompanied by albumin and phosphorus)	< 6.5 mg/dl	> 1000 u/l		
Po2 arterial (pediatrics)	< 45 mmHg	> 125 mmHg	calcium (pediatrics)	< 3.1 mg/dl	> 6.3 mg/dl		
Po2 arterial (newborn)	< 35 mmHg	> 90 mmHg	calcium ionized	< 0.7 mmol/l	> 1.6 mmol/l		
Po2 ven	< 20 mmHg		calcium ionized	< 1 mg/dl	> 4.9 mg/dl		
PCO2	< 20 mmHg	> 70 mmHg	magnesium	< 2 g/dl			
PCO2 (pediatrics)	< 20 mmHg	> 55 mmHg	albumin adults	< 1.7 g/dl			
Bicarbonate	< 10 mEq/L	> 40 mEq/L	albumin pediatrics				
			CK -Total		> 1000 U/L		
			CK-mb		> 24 U/ml		
			ALT		> 1000 u/l		
			Ammonia	< 20 mmol/l	> 187 Ug/dl		
			Anion gap	< 15 mg/dl	> 43 mmol/l		
			bilirubin (newborn until 3 weeks)	< 10 mg/dl			
			bilirubin (3 weeks until 18 years)		> 700 U/L		
			Lipase	< 240 mOsm/kg	> 330 mOsm/Kg		
			Osmolality		> 188 mg/dl		
			Csf protein (pediatrics)				

References: Roberts WL and McMillin GA : Reference information for the clinical laboratory. In: Burtis CA and Bruns DE (Eds) : Textbook of Clinical Chemistry and Molecular Diagnostics; seventh edition St . Pai M, Moffat KA, Plumhoff E, and Hayward CP. Critical values in the coagulation laboratory: results of a survey of the North American Specialized Coagulation Laboratory Association. Am J ClinPathol 2011;136(6):836-841.

- The Canadian Medical Protective Association. Responsibility for follow up of investigations.
- stanfordlab.com/pages/panicvalues.htm#hematology

Radiological critical values list

CNS

- Herniation Syndrome
- Unstable spine fracture – Trauma
- Spinal Cord compression
- Acute intracranial hemorrhage

CHEST

Pneumothorax

Pulmonary embolism

ABDOMEN

- Bowel intussusception
- Bowel obstruction – high grade
- Acute cholecystitis
- Acute appendicitis
- Pneumoperitoneum / portal venous gas / ischemic bowel
- Traumatic visceral injury – on trauma protocol

URO/GENITAL

- Ectopic pregnancy
- Placental abruption
- Fetal demise
- Ovarian torsion
- Testicular torsion

VASCULAR

DVT (Acute)

Arterial dissection

PROCEDURAL

- Retained sponges, sharps, instrumentation or other foreign body

Reference: IOWA Radiology Critical Values Reporting Policy for Radiology 2024

النتائج الإكلينيكية الحرجة للبالغين

ضغط الدم	$\geq 180/110$
	$\leq 90/50$
درجة الحرارة	≥ 40 $35 \leq$
النبض	≥ 120 $40 <$
معدل التنفس	≥ 30 $8 <$
حدوث تزييف حاد	دليل على حدوث نزيف حاد
تغيير في درجة الوعي	≤ 12 او 3 درجات عن درجه وعي المريض
تشنجات	بداية حدوث تشنجات أو حدوث تشنجات لفترة طويلة
نسبة الاكسجين	اقل من او يساوي 90
كميه البول	اقل 1/2 مم /كجم/ ساعة في حاله عدم عدود اعتلال كلوي
Reference: - https://www.researchgate.net/figure/vital-signs-directed-therapyprotocol-figs-287965953 -Media 678204 smxx.pdf	



الهيئة العامة للتأمين الصحي

فرع :

مستشفى :

نموذج التبليغ عن النتائج الحرجة

وقت التبليغ Reporting Time	الوحدة التي تم ابلاغها Unit Reported	اسم الذي تم إبلاغه Receiving Name	اسم المبلغ Reported	النتيجة الحرجة Critical Result	وقت النتيجة Result Time	اسم التحليل / الفحص Test Name	رقم الملف الطبي MRN	أسم المريض Patient Name	التاريخ Date

MR.BL.reac. 1-1